

31. DIAPHRAGME PRATIQUE - 3 TECHNIQUES

DURÉE : 16:09

FICHE PÉDAGOGIQUE

RÉSUMÉ DU COURS

Cette vidéo présente deux techniques de libération du diaphragme, essentielles pour améliorer la fonction respiratoire et l'état général des patients, notamment des enfants. La première technique se concentre sur la jonction œsophagienne et diaphragmatique, exploitant des mouvements spiralés et l'écoute tissulaire pour relâcher la pression au niveau du diaphragme. Le protocole pratique détaillé comprend des étapes d'évaluation de la nuque, de relâchement et de mobilisation, visant à redonner une liberté de mouvement. La deuxième technique vise l'arrière-cavité des épiploons et les insertions œsophagiennes, soulignant l'importance de l'interaction entre les côtes et le diaphragme. Ces approches, ancrées dans la pratique biodynamique, visent le bien-être global du patient.

DIAPHRAGME PRATIQUE - 3 TECHNIQUES

INTRODUCTION AUX TECHNIQUES DIAPHRAGMATIQUES

Nous allons explorer deux techniques principales. La première est une approche **mécanique** pour libérer l'espace diaphragmatique. La seconde est une approche **globale** du diaphragme, particulièrement efficace chez les enfants et les bébés, pour redonner une **expansion optimale**. Cette technique s'inscrit dans une pratique de type **biodynamique**.

TECHNIQUE 1 : LIBÉRATION DE LA JONCTION ŒSOPHAGIENNE ET DIAPHRAGMATIQUE

Nous allons travailler spécifiquement sur le **carrefour** entre l'œsophage et le diaphragme. Cette région est riche en **réseaux nerveux**, notamment avec le tronc du **nerf vague**. L'objectif est de libérer cette zone en douceur, ce qui aura pour effet de décharger toute la zone vagale environnante.

ANATOMIE CLÉ

- Nous observerons la portion diaphragmatique droite et gauche.
- La **plèvre** est également présente ici.
- Il y a un vestige anatomique, anciennement une veine, appelée la **veine de Treitz et Lehmer**.

- Un petit muscle s'insère sur le diaphragme et le péritoine, formant l'espace **péri-œsophagien**. Cet espace a une fonction d'adaptabilité et de rééquilibrage par rapport à la jonction diaphragmatique.
- Cette structure se prolonge avec le **muscle de Treitz**, qui est le ligament suspenseur du duodénum.

LE MOUVEMENT SPIRALÉ DU CORPS

Le corps est souvent organisé en **spirales**, un mouvement puissant que l'on retrouve partout. L'embryon lui-même se développe selon des mouvements spiralés. Nous utilisons les spirales en énergétique pour cibler des points précis. Ici, nous appliquerons ce principe de mouvement spiralé.

PROTOCOLE PRATIQUE

1. **Localisation** : Positionnez-vous au niveau de la jonction, là où vous pouvez avoir accès à la partie la plus haute de l'estomac.

2. Test Préliminaire de la Nuque :

- Tournez la tête vers la gauche et sentez la sensation.
- Revenez au centre, puis tournez la tête à droite.
- Revenez au centre, puis tournez la tête à gauche à nouveau. Notez si la rotation est limitée. Très souvent, cette zone diaphragmatique empêche une bonne rotation de la nuque.

3. Positionnement et Relâchement :

- Positionnez-vous et laissez la personne tomber en arrière vers vous.
- Demandez-lui de se relâcher complètement. Maintenez la personne.
- Gardez un point d'appui avec votre pouce.

4. Descente et Écoute Tissulaire :

- Commencez à descendre doucement, en profondeur. Cherchez les tissus.
- Écoutez les tissus. Observez la respiration de la personne. À l'expiration, descendez et rencontrez une légère butée, une certaine densité.

5. Stabilisation et Mobilisation Progressive :

- Positionnez-vous doucement, en prenant un bon point d'appui postérieur, bien droit, pour être stable.
- Vérifiez que la personne ne ressent pas de douleur.
- Descendez encore, en laissant une petite marge en raison des vêtements.

- Demandez à la personne de se redresser très doucement. Vous pouvez sentir le "hop" remonter avec vous.
- Répétez le mouvement : remontée douce, puis relâchement. Gagnez du terrain.
- Parfois, ressentez un "frein" et cherchez un peu plus loin, en remontant et en redescendant.

6. **Prise Postérieure et Sensation :**

- Prenez ensuite la partie postérieure entre vos deux mains.
- Demandez à la personne de se relâcher complètement. Vérifiez l'absence de douleur excessive.
- Une sensation peut se faire sentir, puis "s'ouvre au niveau de la vésicule".

7. **Vérification Post-Technique :**

- Recherchez un appui postérieur et revenez.
- Demandez à la personne de tourner la tête vers la gauche à nouveau pour vérifier la mobilité.

TECHNIQUE 2 : LIBÉRATION DE L'ARRIÈRE-CAVITÉ DES ÉPIPLOONS ET DE L'ESTOMAC

Cette technique se concentre sur l'arrière-cavité des épiploons et les insertions œsophagiennes. N'oubliez pas l'importance des **côtes** en lien avec le diaphragme, où il y a une concentration importante.

PROTOCOLE PRATIQUE

1. **Localisation :** Placez-vous là où le "trou" se fait.
2. **Positionnement de la Main :** Placez votre main à plat vers la jonction, au niveau des 7e, 8e, 9e côtes.
3. **Glissement et Relâchement :** Glissez votre main en dessous et déposez-la à plat. Ensuite, venez avec l'autre main.
4. **Bras de Levier :** Relâchez et créez un petit bras de levier. Cette zone est un carrefour important de tensions.
5. **Effets :**
 - Cela va relâcher toute la jonction estomac-cardia.
 - Cela va détendre la zone musculaire de Treitz et les structures associées.
 - Cela agit sur cette relation vitale.

SENSATION GLOBALE ET POCHE RÉTROGASTRIQUE

- Concentrez-vous sur une sensation plus globale. Touchez tout le corps.

- La **poche rétrogastrique** est très importante à mobiliser. Les ulcères sont souvent postérieurs et cette poche a besoin de mobilité pour un bon péristaltisme et une bonne fonction. Elle doit être libre.
- Si elle n'est pas bien libre, elle n'est pas libérée par rapport au diaphragme.

LIENS ANATOMIQUES ESSENTIELS

- L'œsophage et l'estomac sont les premiers organes en rapport avec la base du crâne.
- Ils ont une relation avec le **mésogastre postérieur**, la corne et les bronches souches gauches. Vous pouvez sentir la chaleur monter, puis redescendre.

APPROCHE BIODYNAMIQUE ET DÉVELOPPEMENT EMBRYONNAIRE

J'explore maintenant un autre niveau : la force du **développement embryonnaire**, l'appui, la puissance. J'observe la respiration et perçois un travail fascial qui vise à donner plus d'espace entre le diaphragme et la zone pulmonaire postérieure.

LE PLAN PÉRITONÉAL

- Sur le plan péritonéal, l'**angle colique gauche** est le premier point fixe du développement global du péritoine. C'est le premier point d'appui.
- Concentrez-vous sur ce point d'appui, puis sur le point de mobilité.
- Le point le plus mobile est le **caecum**, le dernier à se mettre en place. Évaluez comment il est.
- Entre vos deux mains, vous avez tout l'axe de rotation du cadre colique. Le diaphragme travaille sur ces structures.
- Dans cet espace, vous avez tous les ligaments, comme le **ligament falciforme**.

CHOIX THÉRAPEUTIQUE

Le praticien peut choisir sur quoi travailler, mais souvent le corps du patient guide ce choix.

- Par exemple, une tension sur le ligament falciforme, ou sur son feuillet.
- Parfois, il y a l'expression d'une "gentille colère", comme si l'on manquait d'un point d'appui postérieur, ou qu'il y avait besoin d'une libération ici.
- Ce travail se fait en synchronicité avec la tente du cervelet, la faux du cerveau, au niveau de la **crista galli**. On va travailler sur le sinus.

EXPRESSION DE LA COLÈRE EN BIODYNAMIQUE

La colère peut s'exprimer comme une incapacité à un moment donné à s'exprimer. Cela peut dater de longtemps, lié à ce qui n'a pas pu être dit. En biodynamique, je saisis le protocole en me mettant sur la globalité. Je quitte la respiration thoracique et j'entre dans l'espace, le laissant ouvert. Le corps me guide alors vers des points d'appui. Des "flashes" peuvent apparaître, indiquant une tension.

LA CLÉ DE L'APPROCHE BIODYNAMIQUE (INITIATIQUE)

- Plongez dans l'eau (métaphoriquement).
- Écoutez le mouvement.
- Sentez le mouvement.
- Cherchez la **balance** (le point d'équilibre).
- Une fois que vous avez trouvé le point de balance, écoutez le silence derrière.

Quand les cellules "répondent" et s'ouvrent à la réception, c'est un **"allumage" cellulaire**.

PRÉCAUTIONS ET POSITIONNEMENT DES MAINS

Lorsque l'on aborde le diaphragme, il s'agit de donner de l'espace au diaphragme.

ERREURS À ÉVITER

- **Appuyer sur la tête** : Il faut avoir une sensation équitable entre les mains. Une erreur majeure est d'appuyer sur la tête de la personne, ce qui est très désagréable à la longue.
- **Mauvaise posture** : Ayez un bon appui sur vos coudes.

CONSEILS DE POSITIONNEMENT

Imaginez que vous mangez de l'ail et que vous prenez le bon espace. Il est crucial de trouver le bon espace.

GUIDAGE MÉDITATIF ET ÉTAT DU THÉRAPEUTE

Dans cette pratique, je vous guiderai dans un état **méditatif**.

- Positionnez-vous juste dans la bonne position.
- En tant que receveur, essayez de définir votre ressenti de la position.

SENSATION DE TOUCHER

Le toucher est très léger, avec beaucoup de chaleur. Il est global, on a l'impression qu'il s'étend jusqu'aux pieds. En même temps, il y a cette sensation que je saisis le **"champ micro-cristallin"** : toutes ces cellules, ce petit réseau cellulaire avec leurs récepteurs. C'est un champ énorme.

LE CHAMP DE GLYCOCALYX

Le plus grand lieu de concentration d'informations d'un champ de **glycocalyx** se trouve au niveau du **deuxième duodénum** – la partie la plus informée de l'intestin. Ce champ est présent partout sur le corps, comme un champ global qui englobe tout. Cela permet d'établir un contact profond.